

Rodzina *delfin, nie niedźwiedź*

Bliscy z dobrego serca często pogarszają sytuację (komentarze o wadze, kontrola jedzenia). *Treasure 2016 model „niedźwiedź vs delfin”*. Trening rodziny redukuje wyrażane emocje i poprawia wyniki klienta.

CZAS: 45 min · 1-2 sesje z rodziną · Etap 1-2 CBT-E · za zgodą klienta

ŹRÓDŁO: Treasure i in. (2016); Sepulveda i in. (2010)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **model „niedźwiedź vs delfin”** (sekcja 1), **sześć zasad dla bliskich** (sekcja 2). Sekcja 3 — jak rozmawiać o jedzeniu. Sekcja 4 — opieka nad opiekunami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Psychoedukacja rodziny/partnera — 1-2 sesje dla osób najbliższych klientowi z bulimią. Cele: zmniejszyć stygmatyzację, zmniejszyć *wyrażane emocje*, dać wskazówki, pomóc rodzinie dbać o *siebie*. Treasure i in. (2016) opracowali model **„niedźwiedź i delfin”**: opiekunowie powinni być *delfinami*, nie *niedźwiedziami* (krytyka) ani *kangurami* (nadopieka). Sepulveda i in. (2010): trening rodziny **redukuje wyrażane emocje**. Dla *dorosłego* klienta — **za jego zgodą**. Dla *nastolatków* (FBT, Lock & Le Grange 2013) — rodzice są **kluczowymi partnerami**. Psychoedukacja zapobiega izolacji.

01 ● Model „niedźwiedź vs delfin” Treasure

🐻 NIEDŹWIEDŹ

Krytyczny, kontrolujący. „*Jak długo to potrwa*”, „*weź się w garść*”. Komentarze o wadze. Sprawdzanie. Frustracja. Wysokie *wyrażane emocje*.

🐨 KANGUR

Nadmiernie chroniący. „*Nie pójdziesz na imprezę*”, „*ja wszystko za ciebie zrobię*”. Brak autonomii. Klient nie uczy się radzić sobie.

🐬 DELFIN

Cel. Obok klienta, wspierający, ale z dystansem. Walidacja, zaufanie do procesu terapii. „*Jestem tu, gdy chcesz*”.

Klucz: większość bliskich *oscyluje* między niedźwiedziem a kangurem — z troski. Delfin wymaga *tolerancji niepewności*. Sepulveda i in. (2010): wysokie *wyrażane emocje* korelują z **gorszymi** wynikami.

02 = Sześć zasad dla bliskich

1 · NIE KOMENTUJ WAGI, CIAŁA

Żadnych „*schudłaś*”, „*przytyłaś*”, „*świetnie wyglądasz*”. Nawet „*pozytywne*” komentarze wzmacniają fokus na wadze.

2 · NIE KONTROLUJ JEDZENIA

Nie sprawdzaj co je, nie pilnuj porcji, nie liczy ile zjadła. Terapeuta i klient pracują nad jedzeniem.

3 · NIE MORALIZUJ

„*Powinnaś się postarać*”, „*inni mają gorzej*”. Moralizowanie wzmacnia wstyd → wzmacnia epizody.

4 · WALIDACJA TRUDNOŚCI

„*Wiem, że to trudne*”, „*Jestem tutaj*”. Bez naprawiania, bez rad. Sama obecność uspokaja.

5 · GRANICE — BEZ SPRAWDZANIA

Klient potrzebuje *prywatności*. Bez przeszukiwania śmieci, sprawdzania łazienki. Opieka nad sobą — bliscy też potrzebują wsparcia.

6 · WSPÓŁPRACA Z TERAPEUTĄ

Zaufaj procesowi. Jeśli masz wątpliwości — rozmawiaj z terapeutą (za zgodą klienta), nie z klientem.

CZEGO NIE MÓWIĆ

- „Wyglądasz świetnie / źle”
- „Tylko to jedzenie?”
- „Inni mają gorzej”
- „Po prostu jedz normalnie”
- „Robisz to specjalnie?”

CO MOŻNA MÓWIĆ

- „Jak się czujesz?”
- „Jestem tutaj”
- „Wiem, że to trudne”
- „Kocham Cię, niezależnie”
- „Jak mogę pomóc?”

BLISKA OSOBA, KTÓREJ POTRZEBUJĘ WSPARCIA

— *kto, jaka rola; co tej osobie pomoże dbać o siebie*

MATERIAŁY, KTÓRE CHCĘ IM PRZEKAZAĆ

— *ten handout, książki, kontakty do grup wsparcia rodzin*

Klucz: psychoedukacja rodziny jest *jedną z najsilniejszych* interwencji *poza sesją indywidualną*. Treasure i in. (2016) opracowali *Skills-Based Learning* na podstawie 15 lat badań w Maudsley (Londyn) — model „*niedźwiedź vs delfin*” jest zaczerpnięty z tej tradycji. Sepulveda i in. (2010): w badaniu z rodzinami pacjentów z bulimią i anoreksją *trening rodziny* redukował *wyrażane emocje* o 40–60% i korelował z **lepszymi** wynikami pacjenta. Co więcej: rodzice / partnerzy *sami* doświadczali poprawy jakości życia (mniej depresji, niepokoju, wyczerpania). To *obustronna* korzyść.

Dla dorosłego klienta bulimii: psychoedukacja *wymaga zgody*. Bez niej — łamanie tajemnicy zawodowej. Jeśli klient odmawia, terapeuta może omówić *powody* odmowy (wstyd, lęk przed reakcją, ochrona bliskich) i pracować nad tym jako częścią terapii. **Dla nastolatków:** *Family-Based Treatment* (Lock & Le Grange 2013) czyni rodziców *kluczowymi partnerami* terapii — to standard międzynarodowych wytycznych dla młodzieży z bulimią i anoreksją. **Polskie realia:** dostępność grup wsparcia dla rodzin jest *ograniczona*, ale fundacja „Dobre Życie” i Polskie Towarzystwo Studiów nad Zaburzeniami Odżywiania (PTSnZO) oferują materiały i wsparcie.